



PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN, REGISTRO Y ANÁLISIS DE INCIDENTES CLÍNICOS

1. OBJETIVO.

Establecer la metodología para la notificación, registro y análisis de cuasifallas, eventos adversos y centinela, mediante un sistema estandarizado que permita el análisis de la información para identificar áreas de oportunidad, implementar barreras de seguridad y prevenir su recurrencia, en el marco de la cultura de seguridad del paciente.

2. ALCANCE.

Este procedimiento inicia con la identificación de una cuasifalla, evento adverso o centinela por parte de cualquier miembro del personal y finaliza con el análisis de la información, la implementación de acciones de mejora y la retroalimentación a las áreas involucradas.

Aplica a todo el personal (clínico, administrativo y de apoyo) que labora en el Hospital Santa Margarita.

3. DEFINICIONES.

Cuasifalla: Situación en la que un error médico podría haber derivado en un accidente, una lesión o una enfermedad, pero que no lo hizo, ya fuera por el azar o por una intervención oportuna.

Evento Adverso: Lesión causada por el tratamiento o por una complicación médica, no por la enfermedad de fondo, y que da lugar a una hospitalización prolongada, a una discapacidad en el momento del alta médica, o a ambas cosas.

Evento Centinela: Incidencia imprevista en la que se produce la muerte o una lesión física o psíquica grave, o el riesgo de que se produzca. Una lesión grave comprende específicamente la pérdida de una extremidad o una función.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Actualización: La persona titular de la Jefatura de Calidad.

4.2 Ejecución: Todo el personal del Hospital Santa Margarita que identifique un incidente. El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP).

4.3 Supervisión: La persona titular de la jefatura del área donde ocurre el incidente y el COCASEP o su equivalente.

5. DESARROLLO DEL PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Personal del Hospital Santa Margarita	Identifica la ocurrencia de una cuasifalla, evento adverso o centinela durante el proceso de atención.
5.2	Personal del Hospital Santa Margarita	Prioriza la estabilización y atención del paciente en caso de que el incidente haya generado un daño.
5.3	Personal del Hospital Santa Margarita	Realiza la notificación del incidente a través del Sistema de Registro de Eventos Adversos. El registro es anónimo, voluntario, confidencial y no punitivo, y debe realizarse inmediatamente o tan pronto como sea posible tras la identificación del incidente.
5.4	COCASEP	Recibe y centraliza las notificaciones de todos los incidentes registrados para su posterior gestión y análisis. La participación en este sistema es aprobada por el propio comité.
5.5	COCASEP	Realiza el análisis del incidente según su clasificación: Para Cuasifallas y Eventos Adversos : Realiza un análisis de Patrones y Tendencias al menos cada seis meses. Para Eventos Centinela : Realiza un Análisis Causa-Raíz (ACR) en un periodo no mayor a 45 días desde la ocurrencia del evento.
5.6	COCASEP	Presenta los resultados de los análisis al cuerpo directivo y al personal del Hospital Santa Margarita en sesiones generales. El objetivo es identificar patrones, tendencias, costos y diseñar acciones de mejora.
5.7	Jefaturas de Área y COCASEP	Definen e implementan las acciones y barreras de seguridad derivadas del análisis para prevenir la recurrencia de los incidentes.
5.8	COCASEP	Monitorea la implementación y efectividad de las estrategias de mejora definidas y realiza retroalimentación periódica a los directivos y al personal involucrado.

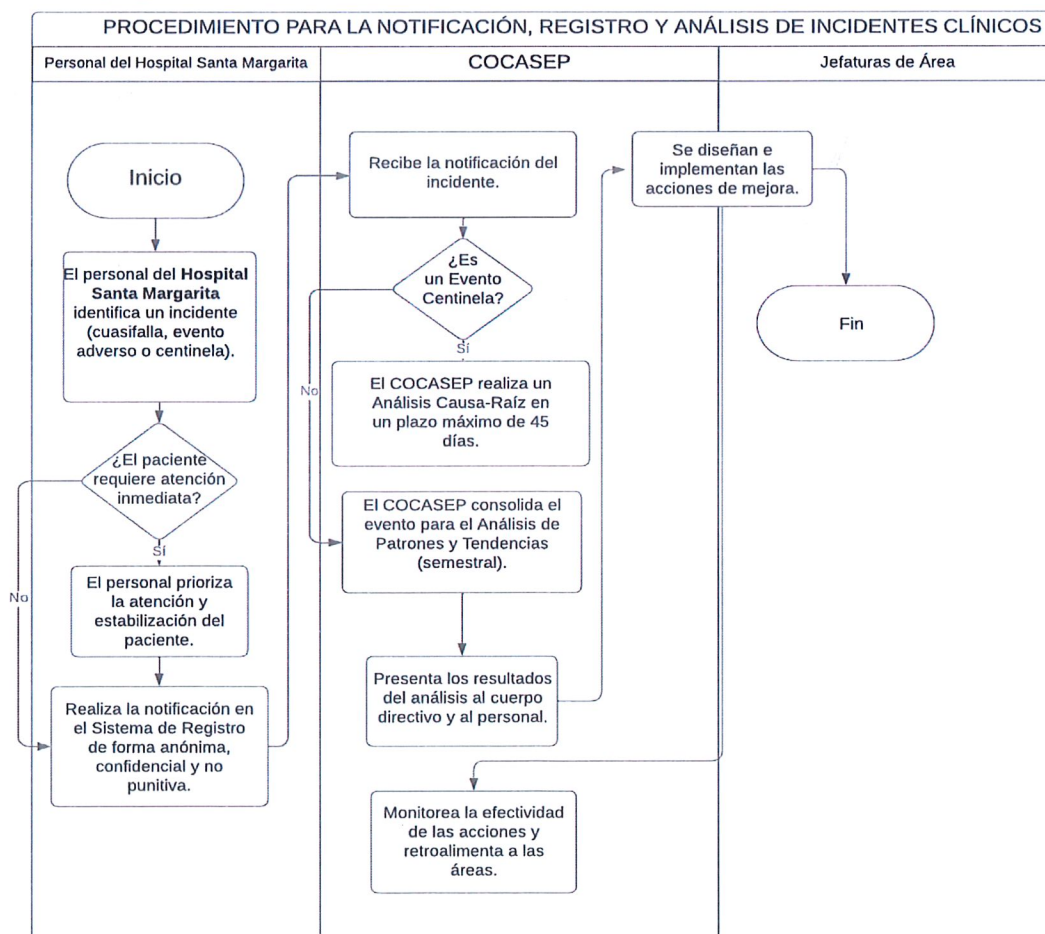
PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN, REGISTRO Y ANÁLISIS DE INCIDENTES CLÍNICOS

6. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Subregistro de incidentes por temor a represalias por parte del personal.	Realizar capacitación continua para fomentar una cultura de seguridad y la importancia del reporte como herramienta de aprendizaje y no de castigo.
b. Análisis superficial del incidente que no identifica las causas raíz.	Aplicar metodologías estandarizadas para el análisis, como el Análisis Causa-Raíz para eventos centinela
c. No se implementan o no se da seguimiento a las acciones de mejora.	Establecer la responsabilidad del COCASEP para monitorear las estrategias de mejora y presentar los avances al cuerpo directivo.

7. ANEXOS

7.1 Flujograma.



7.2 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, Actualización 2023AESP-2023	NA

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	30 Septiembre 2025	Nueva emisión	Dra. Giselle Ivette De la Torre García	Hna. María de Jesús Gómez Flores

9. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dra. Giselle Ivette De la Torre García Jefa de Calidad	 Hna. María de Jesús Gómez Flores Directora Administrativa	 Hna. María de Jesús García Castro Directora General